

République Algérienne démocratique et populaire
Faculté de médecine de Constantine
Dr KH.BOULEMDAIS
Maitre assistante en médecine légale droit medical et éthique

Module : santé société humanité

Première Année médecine

Année universitaire 2025/2026

cours :

La déontologie médicale

Plan du cours

- I.** Introduction
- II.** Origine de la déontologie médicale :
- III.** Le code de la déontologie médicale
- IV.** Sanctions prévues dans le code de déontologie :
- V.** les grands principes déontologiques: liberté des contractants
 - Le libre choix du malade
 - Le consentement éclairé
 - La liberté du médecin
 - La relation médecin malade (soignant-soigné).
- VI.** Conclusion
- VII.** Bibliographie

I. Introduction :

Le mot déontologie est d'origine Grec : « Deontos » : « Ce qu'il faut faire ».

Logos = « Discours ».

La déontologie est l'ensemble des principes, des règles et usages (ensemble des devoirs et des règles professionnelles) que tout médecin doit les appliquer au cours de l'exercice professionnel.

Leur observance est générale et absolue. En cas de non-respect d'une ou de plusieurs règles, le médecin encourt une responsabilité ordinaire (responsabilité source de sanction).

Les règles relatives à la déontologie médicale s'imposent à tout médecin, (ou étudiant en médecine) autorisé à exercer la profession dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Les droits du malade dans la relation médecin /malade sont de plus en plus renforcés et les évolutions sociales notamment en matière de protection de la dignité de la personne, D'accompagnement des personnes en fin de vie, de la recherche biomédicale et de la sécurité des patients sont intégrées dans les règles déontologiques (devoirs des médecins envers les malades).

il existe un code de déontologie médicale qui précise :

*Les devoirs du médecin envers ses confrères.

*Les relations et devoirs du médecin envers les membres des autres professions de santé.

*Les devoirs du médecin envers les malades et la société.

II. Origine de la deontologie medicale :

1) Dans le monde :

elle a des racines anciennes 500 ans av Jésus , le serment d'Hippocrate avait codifié la morale médicale.

En 1948 : Adoption du serment le plus actuel par l'association médicale mondiale à Genève.

2) En Algérie : l'évolution de la déontologie médicale à subi plusieurs étapes :

- Avant 1962 : le code de déontologie français était applicable à tout médecin autorisé à exercer en Algérie.
- A partir de 1963 : création du bureau de surveillance des professions médicales.
- Février 1985 : promulgation de la loi 85/05 relative à la protection et à la promotion de la santé, abrogeant le code de déontologie médicale.
- Juillet 1990 : promulgation de la loi 90-17 modifiant et complétant la loi du 16/02/1985 N° 85/05 relative à la promotion de la santé dans les articles 9, 267 alinéa 1 et Art 267 alinéa

2 « Création du conseil national de déontologie médicale constitué de ses 03 sections ordinales nationales. »

- Avril 1998 : installation officielle au palais de la culture du conseil national de déontologie médicale suite à des élections nationales.

III. Le code de la déontologie médicale

Les fondements de la déontologie médicale sont codifiés en un texte de décrets agencé d'une manière cohérente et classé en titres et chapitres : Le code de déontologie médicale .

Il fait partie de la réglementation officielle , il s'agit d'un texte de loi dont les dispositions s'imposent à tout médecin inscrit au tableau de l'ordre qui doit s'engager sous serment à le respecter et tout manquement à ces dispositions relève des instances disciplinaires du conseil de l'ordre .

Le code de déontologie reprend les principes traditionnels de la pratique médicale , des règles toujours valables depuis le serment d' Hippocrate .

Il affirme les droits des malades , la vocation du médecin: dévouement, respect de la dignité des malades et autant de principes qui constituent les devoirs du médecin .

Le code de déontologie médicale est élaboré par une autorité représentative des professions médicales : le conseil de l'ordre qui est chargé de l'élaboration des règles déontologiques qu'il soumettra par la suite à l'appréciation du conseil d'état .

Il a paru dans le décret exécutif N° 276 du 06/07/1992 et comporte 226 articles repartis sur 05 titres

Il est composé de : titres, chapitres, paragraphes et articles :

Les devoirs généraux de la déontologie médicale ;

Le secret professionnel ;

Les devoirs envers les malades ;

Les devoirs de la confraternité ;

Les rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé ;

Les règles particulières à certains modes d'exercice.

Les dispositions divers.

IV. Sanctions prévues dans le code de déontologie :

⇒ Le conseil saisi d'une plainte doit statuer dans un délai de 04 mois.

⇒ Les sanctions disciplinaires sont :

- L'avertissement ;
- Le blâme ;
- La proposition d'interdire d'exercer ;
- La fermeture de l'établissement.

=> Les sanctions sont susceptibles d'appel ou de recours auprès du conseil national de déontologie médicale, dans un délai de 06 mois.

=> en cas de non-satisfaction, un appel peut à nouveau être introduit auprès de la cour suprême dans un délai de 01 an.

V. les grands principes déontologiques : La liberté des contractants :

1. Le libre choix du malade :

Le médecin doit respecter le droit que possède tout malade de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit.

Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information **loyale, approximative, claire et appropriée** sur son état, **les investigations et les soins** qu'il lui propose. Pour ce qui est des situations complexes, par exemple le refus de soins, il s'agit d'un droit du malade opposant dans certains cas le devoir d'assistance du médecin avec un refus obstiné et déraisonnable du malade.

2. Le consentement éclairé :

Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.

Lorsque le malade est en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir lui informé de ses conséquences

Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité.

3. La liberté du médecin :

L'indépendance du médecin constitue l'une des bases de la déontologie. Elle est l'élément indispensable à la relation médecin/malade, dans le colloque singulier (relation particulière).

Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.

Il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.

4. La relation médecin malade (soignant-soigné) :

Cette relation soignant-soigné fait partie intégrante du contrat de soin (le contrat médical).

La relation médecin-malade est basée sur le principe du respect de la dignité, sur la qualité de l'information délivrée et sur la mise en place d'un projet thérapeutique adéquat et conforme aux données actuelles de la science et accepté par le patient ou la coopération du malade doit jouer un rôle essentiel.

Cette relation de soins évolue avec le temps et s'adapte à l'évolution de la maladie et de la volonté du patient concernant son état de santé

VI. Conclusion :

Le malade correctement et loyalement informé doit constamment manifester sa volonté à travers un consentement libre et dépourvu de toute ambiguïté. Alors que la malade possède le droit absolu d'être respecté et traité avec respect de sa dignité, lors de son passage dans le système de santé. Il est de son droit de bénéficier d'une prise en charge en respecter ses droits fondamentaux.

